课程导入

慢性阻塞性肺疾病诊断、管理和预防全球策略

原始资料 8 份 · 页面中每一条内容均可追溯到原文位置



治疗目标与个体化管理

治疗目标分为两类：

一类旨在缓解和减轻症状的影响，

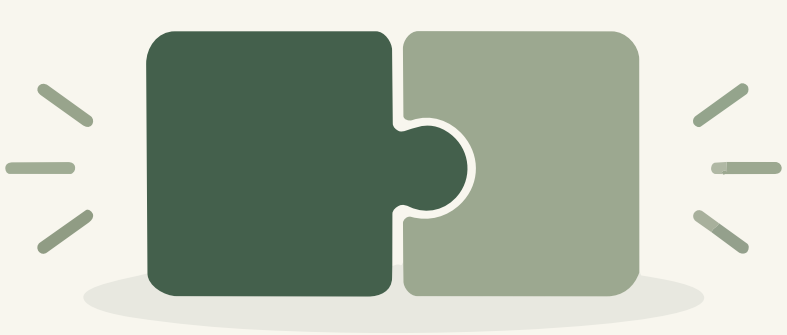
另一类则降低未来可能对患者造成不良健康事件的风险（例如急性加重）。

这种管理方法适用于全球任何临床环境，并将慢性阻塞性肺疾病治疗推向个体化医疗——使患者的治疗更紧密地匹配其需求。

荟萃分析的方法学问题

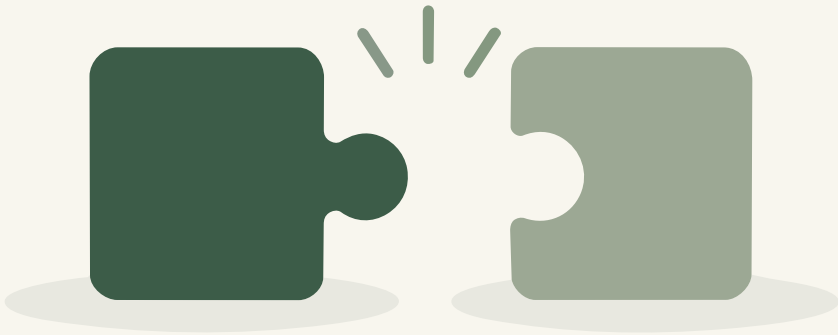
当出现以下情况时，我们仔细考虑了使用荟萃分析证据的方法学问题：

i)治疗效果（或效应量）在不同研究中保持一致，



需要确定共同效应；

ii)效应在不同研究间存在差异，



需找出变异原因。

来源：00_前言和方法学 第2页

肺部异常与气流阻塞

但部分患者可能仅表现为



肺部结构性病变（如肺气肿）

和/或



生理功能异常（包括FEV1降低、气体潴留、过度充气、肺弥散功能下降和/或FEV1快速下降）



而无气流阻塞（支气管扩张后FEV1/FVC≥ 0.7）。

在适当的临床背景下（参见上文'定义'及'病因与危险因素'），



通过肺功能测定检测到

< 0.7

不完全可逆气流受限（支气管扩张后FEV1/FVC< 0.7）



即可确诊慢性阻塞性肺疾病。

来源：01_第1章_定义和概述 第4页

E分类图中的既往急性加重

针对未接受过药物治疗的患者的建议

病史条件	图示分组
EXACERBATION HISTORY (PER YEAR) **One or more (≥ 1) moderate or severe exacerbations in the previous year**	**E**

来源：02_第2章_诊断评估和监测 第23页

症状与气流阻塞不一致

当气流阻塞程度与感知症状存在显著不一致时，

应进行更详细的评估以更好地了解

肺力学
（如全套肺功能检查
和运动试验）、

肺结构
（如CT）

和/或

可能影响患者症状的合并症
（如缺血性心脏病）。

来源：02_第2章_诊断评估和监测 第25页